

ROSANA MARY VENTURINI CAVALI		Prof. Empresária
SINTOMAS / QUEIXAS	Sensibilidade / Aritmia (b'za)	
MEDICAMENTOS	Acoron / Atenolol / Sotulon / Colesterol	
falta de ar. Cansada durante o dia		
HORA QUE DORME:	23 - 23:30	HORA QUE ACORDA: 6:30
BANHEIRO	2 a 3x	SpO ₂ = 93%
TIPO DE RESPIRAÇÃO	nasal	
PRÁTICA EXERCÍCIO	2x / Todos os dias.	19:30
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S. ALMOÇO: S. LANCHE: S. JANTAR: S.		
IDADE: 59	PESO: 24,5	IAH: 22,2 MALLAMPATI: SPO2: 65%
	P=61 A=159	
10/02	P=5,0	
23	IAH=6,7 e/ev	
	M. de uso: 6h 28'	
	Fuga=21. l/min.	
17/02	P=5,0	
23	IAH=6,9 e/ev	
	M. de uso: 6hs	
	fuga=21 l/min.	
09/03	P=5,0 cmH ₂ O	↑ P=4,5
23	IAH=5,7 e/ev	P final 5,0
	M. de uso: 6h 28'	
	Relata melhora da disposição	— fua
19/04	P=6,0 - 4,5 mm	↑ a pressão max. p/ 6,5
23	IAH=5,4 e/ev	
	M. de uso: 7:51'	
	Relata que está roncando.	fua
16/05	P=6,0 - i=5,0	
23	IAH=5,6 e/ev	
	M. de uso: 6:32'	fua
29/07	O crip está e problema	fua
23		
04/09/23	P=6 cmH ₂ O Percentil 90%: 5 cmH ₂ O	
	IAH=3,8 e/ev	
	razamento 21 l/min.	↓ SpO ₂ 90% por 2h30'
	M. de uso: 6h30'	P: 5 a 6,5 cmH ₂ O.
	Sugiro Biologix.	
11/10	P=6 cmH ₂ O	
23	IAH=4,4 e/ev	
	M. de uso: 6h22'	
	Bem adapt.	fua

12/12
23 P = 6,5 cmH₂O
IAH = 4,0 efv
m. de uso: 7h35'
Fuga = 27 l/min.

Tem brupneia no início
da pressão.

fluo.

17/01
24 P = 7,0 cmH₂O
m. de uso: 6h40'
IAH = 4,5 efv
Bem adapt.

fluo Cláudia

06/03
24 P = 7,0 cmH₂O
IAH = 3,8 efv
m. de uso: 7hr.

Relata estar acordando + (x)

15/05
29 P = 6,0 cmH₂O
m. de uso: 6h43'
IAH = 3,0
Bem adaptado

fluo.

10/07
24 P = 6,0 cmH₂O
m. de uso: 6h48'
IAH = 4,0 efv
Fuga = 5 lpm

fluo

11/09/24 P = 6,0 cmH₂O
IAH = 4,2 efv
Fuga = 27 l/min
muro = 7h15 min

naiz conjunto - fazendo uso novo

Silvia

14/11
24 P = 7,0 cmH₂O
IAH = 3,4'
m. de uso = 7h48'

esta bem adaptada, s/
queixas.

fluo.

06/02
25 P = 7,0 cmH₂O.
m. de uso: 7hr
IAH = 2,5 efv
Vazamento: 37 lpm.

Bem adapt.

fluo Cláudia.

Descrição

De: ROSANA MARY VENTURA
Id: F
C: 24,5
Médico solicitante: DR C
COMENTÁRIOS:
Exame:
e latência pa
90,0%. A

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: ROSANA MARY VENTURINE CAVALI			
Sexo: F	Idade: 59 anos	Peso: 62 Kg	Altura: 1,59 m
IMC: 24,5	Data do Exame: 05/12/2022	Exame: 00196_01	
Médico solicitante: DR CARLOS ALBERTO MAXIMO			

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 23:03:15 horas e encerrado às 05:11:51 horas, com latência para o sono de 0 minutos e latência para o sono REM de 50 minutos. O tempo total de sono foi de 332,0 minutos, com eficiência do sono de 90,0%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	1,4%	Até 5%
Estágio 2	57,5%	45 - 55%
Estágio 3	29,2%	> 15%
Sono REM	11,9%	20 - 25%
Eficiência do sono	90,0%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 37 minutos ocorreram **97 despertares (índice de 17,5 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 54 bpm, a maior de 65 bpm e a menor de 50 bpm. Foram identificados **0,0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0,0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 123 eventos respiratórios, sendo 0 central e 123 obstrutivos. Sendo 37 apnéias, 86 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 22,2/hora**, sendo 6,7 apnéia/hora e 15,5 hipopnéia/hora e 0,0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 22,6 e a duração máxima de 51,5.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 50,1/hora, sendo 6,1 apnéia/hora e 44,1 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0,0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0,0 segundos, com duração máxima de 0,0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 93%**, sendo a saturação média de 87%, a maior de 97% e a mínima de 65%, permanecendo 299,6 minutos (81,2%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 2,6 minutos (0,7%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 199 dessaturações. Índice de dessaturações: 36,0/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 62,0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 32,0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau moderado (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Registro de ronco.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono normal.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264